

Guía del articulador semiajustable

Arco facial, montaje y los dos registros · Tema VII del programa

Para qué sirve realmente un articulador

Un articulador es un instrumento mecánico que reproduce la relación entre el maxilar y la mandíbula, y que permite simular los movimientos mandibulares fuera de la boca. Esa es la definición. Lo que importa entender es **por qué se necesita**: en boca no puedes ver los contactos posteriores durante un movimiento de lateralidad, la lengua y el carrillo estorban, y el paciente se cansa. En el articulador esos contactos quedan a la vista y puedes analizarlos con calma.

La palabra **semiajustable** significa que puedes ajustar algunos parámetros del paciente —inclinación de la trayectoria condílea y ángulo de Bennett— pero no todos. No reproduce el movimiento real completo, lo aproxima. Para diagnóstico de oclusión y para férulas esa aproximación es suficiente.

Los tres tipos, para ubicarte

Tipo	Qué hace	Uso típico
No ajustable (de bisagra)	Solo abre y cierra en un eje fijo. No reproduce lateralidad ni protrusión.	Modelos de estudio, trabajos de una sola unidad.
Semiajustable	Ajusta trayectoria condílea y ángulo de Bennett con valores del paciente o promedio.	Diagnóstico de oclusión, férulas, prótesis parcial y total. Es el de tu curso.
Totalmente ajustable	Reproduce el movimiento individual del paciente mediante registros pantográficos.	Rehabilitación oral completa. Requiere pantógrafo y mucho tiempo clínico.

NOTA · Un articulador de bisagra **no sirve** para analizar interferencias en movimiento. Si tu diagnóstico depende de ver el lado de trabajo y el de balance, necesitas mínimo un semiajustable.

El arco facial: qué registra y qué no

Es el punto que más se malentiende. El arco facial **no registra la oclusión** y no tiene nada que ver con cómo muerde el paciente. Lo que registra es la posición del maxilar superior respecto al **eje de bisagra terminal**, es decir, respecto al eje imaginario alrededor del cual rota la mandíbula en su movimiento de apertura inicial.

La consecuencia práctica: si montas el modelo superior sin arco facial, el radio de rotación del articulador no coincide con el del paciente. Al cerrar, los modelos siguen un arco de cierre distinto al real, y los contactos que observes serán falsos. Mientras más te alejes de la posición de registro, mayor el error.

Arbitrario contra cinemático

	Arbitrario	Cinemático
Cómo localiza el eje	Usa puntos anatómicos promedio, normalmente los conductos auditivos externos.	Localiza el eje real del paciente con un registrador de eje de bisagra.
Precisión	Error aceptable de hasta unos 5 mm respecto al eje real.	Localiza el eje verdadero, con error mínimo.
Tiempo	Pocos minutos.	Considerablemente mayor.
Cuándo se usa	La mayoría de los casos: diagnóstico, férulas, prótesis convencional.	Rehabilitaciones extensas con cambio de dimensión vertical.

En tu laboratorio vas a trabajar con arco facial **arbitrario**. Es lo correcto para el nivel y para los objetivos del curso.

CAUIDADO · Error frecuente: apretar los tornillos en desorden. Si aprietas primero el brazo de la horquilla y después la referencia anterior, el arco se desplaza y arrastra la horquilla. Respeta siempre el orden que indica el fabricante de tu sistema.

Los cuatro sistemas del laboratorio

Los cuatro son semiajustables y los cuatro sirven para el mismo objetivo. Lo que cambia es la referencia anterior, el sistema de transferencia y la forma de fijar los modelos.

Sistema	Referencia anterior	Transferencia	Particularidad
Whip Mix 2240 / 3040	Nasion, con posicionador propio	El arco completo se lleva al articulador sobre un soporte de montaje.	El más difundido en escuelas. Tres puntos de apoyo bien definidos.
Bio-Art A7 Plus / A7 Fix	Apoyo nasal ajustable	Mesa de transferencia independiente.	Platinas de encastre: puedes quitar y volver a poner el modelo sin perder posición.
Dentatus ARH / ARL	Raíz nasal	El arco se acopla directo al articulador, sin mesa intermedia.	Construcción metálica y diseño simple. Revisa holguras antes de montar.
Panadent PSH / PCH	Plano axio-orbitario	Soporte de transferencia propio, con referencia orbitaria.	Permite localización cinemática del eje. El más preciso y el más laborioso.

NOTA · En Dentipedia puedes cambiar de articulador dentro de Step by Dent y los pasos del arco facial se adaptan solos al sistema que elijas.

Los dos registros del Tema VII

El programa pide montar en dos posiciones distintas. No es un capricho: la comparación entre ambas es justamente el hallazgo diagnóstico.

Relación céntrica

Posición determinada por la **articulación**, no por los dientes. Los cóndilos se ubican en su posición más superoanterior contra la vertiente posterior de la eminencia articular, con el disco correctamente interpuesto. Es independiente del contacto dentario y, sobre todo, es **reproducible**: puedes volver a ella las veces que quieras. Por eso sirve como referencia de diagnóstico.

Posición habitual de conveniencia

También llamada máxima intercuspidación. Es donde el paciente cierra por costumbre, guiado por sus propios dientes. La determina la **oclusión**, no la articulación. Puede coincidir con relación céntrica o estar desplazada respecto a ella.

El deslizamiento entre ambas

La distancia que recorre la mandíbula desde el primer contacto en céntrica hasta la posición habitual se llama deslizamiento en céntrica. Un deslizamiento pequeño y simétrico se considera fisiológico. Uno amplio, o con componente lateral marcado, es un hallazgo que debe documentarse: indica que el paciente está evitando una interferencia, y ese desvío tiene costo muscular y articular.

CAUTION · Este es el punto de toda la práctica. El montaje no es el objetivo: es la herramienta que te permite medir ese deslizamiento y localizar la interferencia que lo provoca. Es el vínculo directo con el Tema II del programa.

Desprogramación: por qué es indispensable

La musculatura tiene memoria de la posición habitual. Si pides al paciente que cierre sin más, va a ir a su mordida de siempre y vas a registrar la posición equivocada. Desprogramar significa romper temporalmente ese patrón muscular: con un tope anterior, un rodillo de algodón entre los dientes durante unos minutos, o con manipulación bimanual. Sin desprogramar, tu registro de céntrica no es de céntrica.

Sobre la cera del registro

La cera rosa toda estación se ablanda mucho a temperatura bucal y puede deformarse al retirarla. Para la Práctica 1 es aceptable porque el objetivo es aprender la maniobra. Para un montaje que vas a analizar, considera cera azul de registro o silicona de registro: son más estables dimensionalmente y el montaje resultante es más confiable.

Secuencia general de montaje

Los pasos específicos de tu sistema están en Step by Dent. Esta es la lógica de fondo, que no cambia entre articuladores.

1. Verificar los modelos: secos, sin burbujas, estables al ocluir y con retenciones en la base.
2. Preparar el articulador: limpio, sin juego, vástago incisal en cero.
3. Tomar el arco facial en el paciente, con la técnica de tu sistema.

4. Transferir el arco al articulador y montar el **modelo superior** con yeso tipo II.
5. Tomar el registro en **relación céntrica**, previa desprogramación.
6. Invertir el articulador y montar el **modelo inferior** contra el superior, usando el registro.
7. Tomar el registro en **posición habitual** y montar un segundo inferior, o remontar con platina intercambiable.
8. Verificar: los modelos deben ocluir igual con y sin registro.
9. Analizar: primer contacto, deslizamiento, interferencias de trabajo y de balance, guía anterior.

NOTA · El modelo se vacía en yeso **tipo III**; el montaje y el zócalo se hacen en **tipo II**, que es más blando y fácil de recortar. Usar tipo III para montar es desperdiciar material y trabajo de recorte.

Errores que arruinan el montaje

Error	Consecuencia
Presionar al cerrar sobre el registro de cera	Se hunde el registro y el montaje queda con la dimensión vertical disminuida.
No apoyar el modelo cuando queda en voladizo	El peso del yeso fresco baja el modelo y el montaje se desvía.
Modelos con burbujas o nódulos en cúspides	Contactos falsos: vas a diagnosticar una interferencia que no existe.
Omitir las retenciones en la base	El modelo se desprende de la platina y hay que rehacer todo.
Registrar sin desprogramar	Registras la posición habitual creyendo que es céntrica. Todo el análisis queda inválido.
Mover el arco al apretar los tornillos	El plano de referencia queda inclinado y el modelo superior mal orientado.
Manipular antes del fraguado completo	Micromovimientos que desplazan el modelo sin que lo notes.

· Esta guía acompaña la práctica de montaje del Tema VII. Los pasos detallados de tu articulador, con lista de verificación y Modo Práctica, están en **dentipedia.dentilike.com.mx**